TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARINDA FAKTÖR V LEİDEN VE PROTROMBİN GEN POLİMORFİZMLERİ

Ayşe Gül ÇİÇEK
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Prof. Dr. Necat İMİRZALIOĞLU
Tez No: 2026-001
Afyonkarahisar

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ

TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARINDA FAKTÖR V LEİDEN VE PROTROMBİN GEN POLİMORFİZMLERİ

Hazırlayan
Ayşe Gül ÇİÇEK

Danışman
Prof. Dr. Necat İMİRZALIOĞLU

2. Danışman
Doç. Dr. Gökhan IŞIK

Tez No: 2026-001

AFYONKARAHİSAR

Bu tez çalışması; Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPK) Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: "00.SAĞ.BİL.00"

TEZ KABUL VE ONAY SAYFASI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü **Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'nda**. Ayşe Gül ÇİÇEK tarafından hazırlanan "Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Faktör V Leiden ve Protrombin Gen Polimorfizmleri" adlı tez çalışması Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca 15 / 01 / 2026 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından **oy birliği** ile **YÜKSEK LİSANS TEZİ** olarak kabul edilmiştir

Başkan
Prof. Dr. Ahmet YILMAZ, Afyon Kocatepe Üniversitesi
İmza

Üye
Prof. Dr. Fatma DEMİR, Ankara Üniversitesi
İmza

Üye
Doç. Dr. Mehmet KAYA, Ege Üniversitesi
İmza

Üye
Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞAHİN, AKÜ
İmza

Üye
Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZTÜRK, AKÜ
İmza

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun
…… / …… / …… tarih; …..:…… saat ve
…… sayılı kararıyla onaylanmıştır.

…….
Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Ahmet YILDIZ

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bilimsel Yayın Etiği İlkeleri ve Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmasında;

- Tez içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu,
- Başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu,
- Atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak gösterdiğimi,
- Kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,
- Bu tezin herhangi bir bölümünü Afyon Kocatepe Üniversitesi veya başka bir üniversitede başka bir tez çalışması olarak sunmadığımı

beyan ederim.

15 / 01 / 2026
İmza
Ayşe Gül ÇİÇEK

ÖZET

Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Faktör V Leiden ve Protrombin Gen Polimorfizmleri

Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir.

Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020).

Anahtar Kelimeler: dijital okuryazarlık, çevrimiçi öğrenme, öğretmen adayı, öz yeterlik, uzaktan eğitim

SUMMARY

Investigation of the Relationship of Factor V Leiden and Prothrombin G20210A Gene Polymorphisms with Maternal Age, Body Mass Index and Clinical Course in Recurrent Pregnancy Losses by Multivariate Analyses

The gene polymorphisms were examined in detail with respect to clinical findings and laboratory values in the study group. The gene polymorphisms were examined in detail with respect to clinical findings and laboratory values in the study group. The gene polymorphisms were examined in detail with respect to clinical findings and laboratory values in the study group. The gene polymorphisms were examined in detail with respect to clinical findings and laboratory values in the study group. The gene polymorphisms were examined in detail with respect to clinical findings and laboratory values in the study group. The gene polymorphisms were examined in detail with respect to clinical findings and laboratory values in the study group. The gene polymorphisms were examined in detail with respect to clinical findings and laboratory values in the study group. The gene polymorphisms were examined in detail with respect to clinical findings and laboratory values in the study group.

Keywords: digital literacy, online learning, pre-service teacher, self-efficacy, distance education

ÖNSÖZ

Bu çalışmanın hazırlanmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Destek veren kuruluşlara şükranlarımı sunarım.

Ayşe Gül ÇİÇEK

Afyonkarahisar

2026

İÇİNDEKİLER

	SAYFA
TEZ KABUL VE ONAY SAYFASI	**ii**
BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ	**iii**
ÖZET	**iv**
SUMMARY	**v**
ÖNSÖZ	**vi**
İÇİNDEKİLER	**vii**
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ	**ix**
ŞEKİLLER DİZİNİ	**x**
ÇİZELGELER DİZİNİ	**xi**
RESİMLER DİZİNİ	**xii**
1. GİRİŞ	**1**
1.1. Konunun Önemi	1
1.1.1. Tarihçe	1
1.2. Amaç	2
2. MATERYAL ve METOT	**3**
2.1. Çalışma Grubu ve Örneklem	4
2.1.1. Katılımcı Seçimi ve Dışlama Ölçütleri	5
2.2. Laboratuvar Yöntemleri ve Analizler	5
2.2.1. İstatistiksel Çözümleme	6
3. BULGULAR	**8**
3.1. Betimleyici Bulgular	8
3.2. Karşılaştırmalı Bulgular	11
3.2.1. Alt Grup Analizleri	12
3.3. İkinci Bulgu Grubu	13
4. TARTIŞMA	**14**
4.1. Bulguların Literatürle Karşılaştırılması	14
4.1.1. Sınırlılıklar	15
5. SONUÇ ve ÖNERİLER	**16**
5.1. Öneriler	16
6. KAYNAKLAR	**17**

7. EKLER **18**
7.1. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Kararı 18
7.2. Anket Formu 19
7.3. Veri Toplama Formu 20
ÖZGEÇMİŞ **21**

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

%: Yüzde
ANOVA: Analysis of Variance
FVL: Faktör V Leiden
SS: Standart sapma

ŞEKİLLER DİZİNİ

	SAYFA
Şekil 2.1: Araştırma akış şeması ve örneklerin işlenmesi	6
Şekil 3.1: Parametrelerin gruplara göre dağılımı	10

ÇİZELGELER DİZİNİ

SAYFA

Çizelge 3.1: Katılımcıların demografik ve klinik özellikleri 8

Çizelge 3.2: Gruplara göre ölçüm sonuçları 13

RESİMLER DİZİNİ

SAYFA

Resim 3.1: Deney düzeneğinin görüntüsü 12

1. GİRİŞ

Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur.

1.1. Konunun Önemi

Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.

1.1.1. Tarihçe

Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş,

anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.

1 Erken Dönem

Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir.

1.2. Amaç

Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir.

2. MATERYAL ve METOT

Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020).

Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024).[1] Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir.

Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir.

[1] Dipnot 1: Çalışma tek merkezlidir.

Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir.

2.1. Çalışma Grubu ve Örneklem

Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024).

Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir.[2] Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024).

[2] Dipnot 2: Dışlama ölçütleri ayrıca listelenmiştir.

2.1.1. Katılımcı Seçimi ve Dışlama Ölçütleri

Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024).

1 Kan Örneklerinin Alınması

Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir.

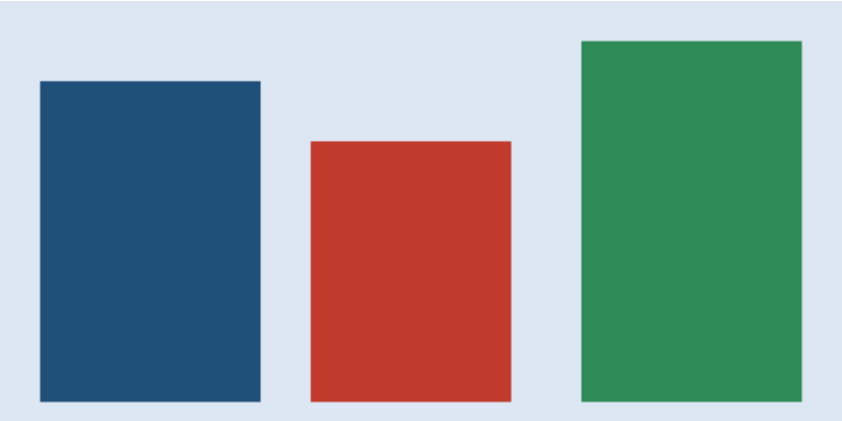
2.2. Laboratuvar Yöntemleri ve Analizler

Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Bu

bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024).

$$E = m c^2 \tag{2.1}$$

Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.



Şekil 2.1: Araştırma akış şeması ve örneklerin işlenmesi

2.2.1. İstatistiksel Çözümleme

Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar,

2020). Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020).

3. BULGULAR

Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024).

3.1. Betimleyici Bulgular

Çizelge 3.1: Katılımcıların demografik ve klinik özellikleri

Sıra	Değişken	Ortalama	SS	p
1	Parametre 1	10.00	1.00	0,10
2	Parametre 2	10.37	1.05	0,17
3	Parametre 3	10.74	1.10	0,24
4	Parametre 4	11.11	1.15	0,31
5	Parametre 5	11.48	1.20	0,38
6	Parametre 6	11.85	1.25	0,45
7	Parametre 7	12.22	1.30	0,52
8	Parametre 8	12.59	1.35	0,59
9	Parametre 9	12.96	1.40	0,66
10	Parametre 10	13.33	1.45	0,73
11	Parametre 11	13.70	1.50	0,80
12	Parametre 12	14.07	1.55	0,87
13	Parametre 13	14.44	1.60	0,94
14	Parametre 14	14.81	1.65	0,11
15	Parametre 15	15.18	1.70	0,18
16	Parametre 16	15.55	1.75	0,25
17	Parametre 17	15.92	1.80	0,32

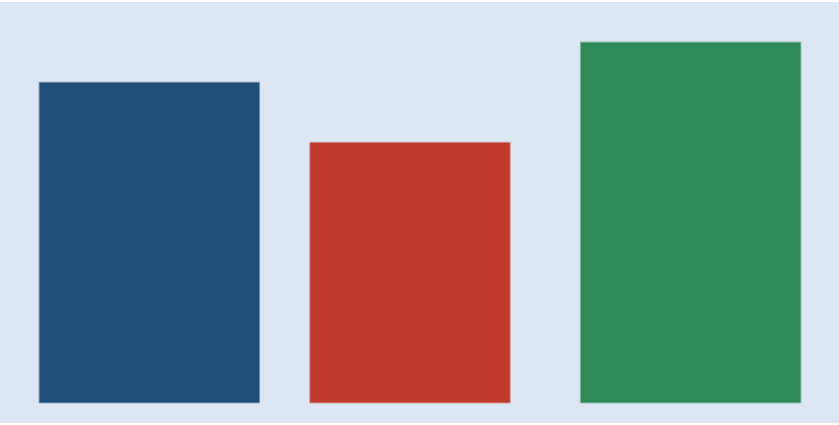
Çizelge 3.1. Devam.

Sıra	Değişken	Ortalama	SS	p
18	Parametre 18	16.29	1.85	0,39
19	Parametre 19	16.66	1.90	0,46
20	Parametre 20	17.03	1.95	0,53
21	Parametre 21	17.40	2.00	0,60
22	Parametre 22	17.77	2.05	0,67
23	Parametre 23	18.14	2.10	0,74
24	Parametre 24	18.51	2.15	0,81
25	Parametre 25	18.88	2.20	0,88
26	Parametre 26	19.25	2.25	0,95
27	Parametre 27	19.62	2.30	0,12
28	Parametre 28	19.99	2.35	0,19
29	Parametre 29	20.36	2.40	0,26
30	Parametre 30	20.73	2.45	0,33
31	Parametre 31	21.10	2.50	0,40
32	Parametre 32	21.47	2.55	0,47
33	Parametre 33	21.84	2.60	0,54
34	Parametre 34	22.21	2.65	0,61
35	Parametre 35	22.58	2.70	0,68
36	Parametre 36	22.95	2.75	0,75
37	Parametre 37	23.32	2.80	0,82
38	Parametre 38	23.69	2.85	0,89
39	Parametre 39	24.06	2.90	0,96
40	Parametre 40	24.43	2.95	0,13
41	Parametre 41	24.80	3.00	0,20
42	Parametre 42	25.17	3.05	0,27
43	Parametre 43	25.54	3.10	0,34
44	Parametre 44	25.91	3.15	0,41
45	Parametre 45	26.28	3.20	0,48
46	Parametre 46	26.65	3.25	0,55

*Kısaltma açıklamaları: SS: Standart sapma; p: anlamlılık düzeyi.

Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024).

Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024).[3] Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020).



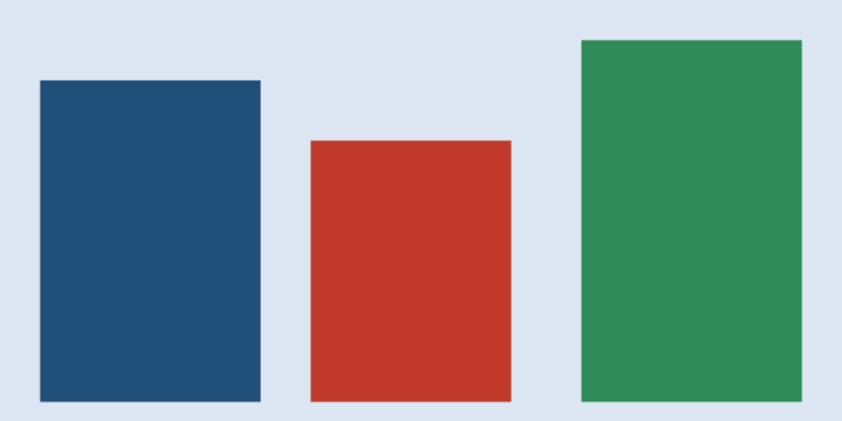
Şekil 3.1: Parametrelerin gruplara göre dağılımı

[3] Dipnot 3: Tablo çok sayfalıdır.

Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024).

3.2. Karşılaştırmalı Bulgular

Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.



Resim 3.1: Deney düzeneğinin görüntüsü

3.2.1. Alt Grup Analizleri

Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur.

1 Yaş Gruplarına Göre

Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir

düzeyde bulunmuştur. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.

3.3. İkinci Bulgu Grubu

Çizelge 3.2: Gruplara göre ölçüm sonuçları

Sıra	Değişken	Ortalama	SS	p
1	Parametre 1	10.00	1.00	0,10
2	Parametre 2	10.37	1.05	0,17
3	Parametre 3	10.74	1.10	0,24
4	Parametre 4	11.11	1.15	0,31
5	Parametre 5	11.48	1.20	0,38
6	Parametre 6	11.85	1.25	0,45
7	Parametre 7	12.22	1.30	0,52
8	Parametre 8	12.59	1.35	0,59

Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020).

4. TARTIŞMA

Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020).

4.1. Bulguların Literatürle Karşılaştırılması

Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.

4.1.1. Sınırlılıklar

Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020).

5. SONUÇ ve ÖNERİLER

Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Ölçüm araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile sınanmış ve kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Gruplar arası farklar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir.

5.1. Öneriler

- Daha geniş örneklemli çalışmalar yapılmalıdır
- Çok merkezli izlem önerilir

Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir. Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir.

6. KAYNAKLAR

YazarA, A., Başka, B. (2010). Örnek makale başlığı numara 1. *J Ethnopharmacol*, 1(2): 10-20.

YazarB, B., Başka, B. (2011). Örnek makale başlığı numara 2. *J Ethnopharmacol*, 2(2): 11-21.

YazarC, C., Başka, B. (2012). Örnek makale başlığı numara 3. *J Ethnopharmacol*, 3(2): 12-22.

YazarD, D., Başka, B. (2013). Örnek makale başlığı numara 4. *J Ethnopharmacol*, 4(2): 13-23.

YazarE, E., Başka, B. (2014). Örnek makale başlığı numara 5. *J Ethnopharmacol*, 5(2): 14-24.

YazarF, F., Başka, B. (2015). Örnek makale başlığı numara 6. *J Ethnopharmacol*, 6(2): 15-25.

YazarG, G., Başka, B. (2016). Örnek makale başlığı numara 7. *J Ethnopharmacol*, 7(2): 16-26.

YazarH, H., Başka, B. (2017). Örnek makale başlığı numara 8. *J Ethnopharmacol*, 8(2): 17-27.

YazarI, I., Başka, B. (2018). Örnek makale başlığı numara 9. *J Ethnopharmacol*, 9(2): 18-28.

YazarJ, J., Başka, B. (2019). Örnek makale başlığı numara 10. *J Ethnopharmacol*, 10(2): 19-29.

YazarK, K., Başka, B. (2020). Örnek makale başlığı numara 11. *J Ethnopharmacol*, 11(2): 20-30.

YazarL, L., Başka, B. (2021). Örnek makale başlığı numara 12. *J Ethnopharmacol*, 12(2): 21-31.

YazarM, M., Başka, B. (2022). Örnek makale başlığı numara 13. *J Ethnopharmacol*, 13(2): 22-32.

YazarN, N., Başka, B. (2023). Örnek makale başlığı numara 14. *J Ethnopharmacol*, 14(2): 23-33.

YazarO, O., Başka, B. (2024). Örnek makale başlığı numara 15. *J Ethnopharmacol*, 15(2): 24-34.

YazarP, P., Başka, B. (2025). Örnek makale başlığı numara 16. *J Ethnopharmacol*, 16(2): 25-35.

YazarQ, Q., Başka, B. (2026). Örnek makale başlığı numara 17. *J Ethnopharmacol*, 17(2): 26-36.

YazarR, R., Başka, B. (2027). Örnek makale başlığı numara 18. *J Ethnopharmacol*, 18(2): 27-37.

YazarS, S., Başka, B. (2028). Örnek makale başlığı numara 19. *J Ethnopharmacol*, 19(2): 28-38.

YazarT, T., Başka, B. (2029). Örnek makale başlığı numara 20. *J Ethnopharmacol*, 20(2): 29-39.

YazarU, U., Başka, B. (2030). Örnek makale başlığı numara 21. *J Ethnopharmacol*, 21(2): 30-40.

YazarV, V., Başka, B. (2031). Örnek makale başlığı numara 22. *J Ethnopharmacol*, 22(2): 31-41.

7. EKLER

7.1. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Kararı

Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Elde edilen veriler, ilgili literatürde bildirilen sonuçlarla karşılaştırıldığında benzer eğilimler gözlenmiştir.

7.2. Anket Formu

Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024). Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Örneklem büyüklüğü, güç analizi ile belirlenmiş ve etik kurul onayı alınmıştır (Karasar, 2020). Bu bulgular, erken tanının önemini vurgulamakta ve ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır (Özdemir ve Işık, 2024).

7.3. Veri Toplama Formu

Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir. Hastaların klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve demografik özellikleri ayrıntılı biçimde kaydedilmiştir.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Ayşe Gül ÇİÇEK

Doğum Yeri ve Tarihi : Afyonkarahisar, 01.01.1995

Yabancı Dili : İngilizce